

IPE 기반 의료역량 강화 프로그램 개발과 적용

1차년도 성과 정리본 · 2025~2026

의학·간호·약학·사회복지·병원 현장의 협업을 교육으로 구현하기 위한 국내 IPE 핵심역량 체계와 프로그램 설계 기반을 마련했습니다.

홈페이지에 공개된 주요 결과와 세부 성과를 모은 자료입니다. 원본 보고서와 구분됩니다.

핵심 성과

5개 영역 · 20개 역량 진술문

17개 기관 · 의대 11·동반 대학 6

59명 · 1개교 시범운영

- 해외 협업 역량 프레임워크와 국내 운영 사례를 분석하고 전문가 합의를 통해 핵심역량을 도출했습니다.
- IPEC 2023의 네 영역과 대응하면서 자기성찰과 팀성찰을 추가한 다섯 영역으로 구성했습니다.
- 각 영역의 정의와 20개 역량 진술문을 확정하고 IPE 프로그램 설계안을 개발했습니다.
- IPE 프로그램 사례 조사 양식과 적용 예시를 마련했으며, 전국 대학의 운영 사례 자료 취합은 진행 중입니다.
- 회의·워크숍·세미나 6회를 개최했으며 개발 산출물은 3종입니다.

주요 산출물

- IPE 핵심역량 체계
- IPE 역량체계-KAMC 기본의학교육 졸업성과 매칭표
- IPE 프로그램 사례 조사 양식 및 적용 예시

세부 성과 목차

- 01 · 추진 배경 및 이론적 배경
- 02 · 과제 목표 및 성과지표
- 03 · 추진 체계 및 방법
- 04 · 추진 경과 및 실적
- 05 · 주요 결과 및 성과물
- 06 · 성과지표 달성도 및 자체평가
- 07 · 성과 확산 및 활용 방안
- 08 · 추진 과정의 쟁점·애로사항 및 개선 방안

01 추진 배경 및 이론적 배경

1. 추진 배경 및 필요성

가. 정책·제도적 배경

의과대학 학제의 통합 6년제 전환과 의학교육 여건 변화에 따라, 졸업 시점에 요구되는 협력 역량을 명시적으로 규정하고 교육과정에 배치할 필요가 커지고 있다.

2025년 의과대학 정원 확대 발표 이후, 의과대학은 늘어나는 학생 수에 대응하여 교육의 질을 유지·향상하기 위한 교육과정 혁신을 추진하고 있다. 통합 6년제 학제 전환은 임상 진입 시점의 재설계를 수반하며, 졸업생이 다직종 팀에서 협업할 수 있는 역량을 체계적으로 갖추도록 교육과정 내 IPE의 배치가 요구된다.

국제적으로 보건의료인력 양성 정책은 전문직 간 협업 역량을 필수 요소로 포함하는 방향으로 전환되었다. WHO(2010)는 「Framework for Action on Interprofessional Education and Collaborative Practice」를 통해 IPE와 협업적 실천(collaborative practice)을 연결하는 정책 프레임워크를 제시하였고, 미국(IPEC, 2011; 2016; 2023), 캐나다(CIHC, 2010), 호주(Curtin University), 일본 등에서 IPE 핵심역량 프레임워크를 개발·개정해 왔다. 국내에서는 KAMC 기본의학교육 졸업성과 제2판(2026)이 '협력'을 졸업성과에 포함하고 있으나, IPE에 특화된 역량 체계는 마련되어 있지 않다.

의료기관 인증기준의 변화도 IPE의 제도적 근거를 강화하고 있다. 의학교육 분야의 국제 인증기준(WFME, 2015; LCME 등)은 다전문직 교육 경험을 교육과정 내에 포함할 것을 권고하고 있으며, 국내 의과대학 평가인증 기준에서도 전문직 간 교육에 대한 요구가 점차 구체화되고 있다.

나. 의학교육 현장의 문제 인식

현행 의과대학 교육과정은 의학 단일 전공 중심으로 편성되어 있어, 학생들이 졸업 전까지 타 보건의료 전공 학생과 함께 학습하는 기회가 구조적으로 제한되어 있다. 임상실습 과정에서 간호사, 약사 등 타 직종과의 접촉이 발생하지만, 이는 교육적으로 설계된 협업 경험이 아니라 자연발생적인 노출에 그치는 경우가 대부분이다.

보건의료 현장에서는 환자안전 사고의 주요 원인 중 하나로 전문직 간 의사소통 실패와 팀워크 부족이 지속적으로 보고되고 있다. 그러나 이러한 협업 역량은 졸업 후 수련 과정에서 비체계적으로 습득되는 데 머물러 있어, 학부 교육과정 단계에서의 체계적 교육이 요구된다.

국내 일부 대학에서 IPE 프로그램을 운영하고 있으나, 대부분 비교과 단발성 프로그램으로 운영되며, 정규 교과로 편성하여 지속적으로 운영하는 사례는 극히 제한적이다. 학사일정 조율, 참여 대학 간 행정 절차, 교수 인센티브 등 운영상 장벽이 높아, 역량 체계와 프로그램 모형이 공통 준거로 제공되지 않으면 각 대학이 독자적으로 IPE를 도입·운영하기 어려운 실정이다.

다. 본 과제가 해결하고자 한 문제(problem statement)

본 과제는 다음 두 가지 문제를 해결하고자 하였다.

① 국내 의과대학생 및 보건의료전공계열 학생을 위한 IPE 핵심역량 체계의 부재

국내에는 ㉠ 국제 프레임워크와 비교 가능하고, ㉡ 학생 수준에서 관찰·평가 가능하며, ㉢ 의학 이외 보건의료 전문직을 포함한 다전문직 전문가의 합의에 기반한 IPE 핵심역량 체계가 존재하지 않는다. 이로 인해 각 의과대학은 IPE 교육과정을 설계할 때 자체적으로 설정하거나 해외의 역량을 차용하여 적용해왔다.

전문직 간 협업 역량은 그 속성상 단일 전문직의 관점만으로 규정할 수 없고, 실제 IPE 또한 의과대학생과 타 보건의료계열 학생이 함께 참여하는 형태로 운영된다. 이에 본 과제는 의학·간호·약학·사회복지·병원 현장의 다전문직 전문가로 패널을 구성하여 의과대학생 및 보건의료계열 전공 학생들이 IPE 프로그램을 통해 개발할 것으로 기대되는 역량체계를 개발하고자 하였다.

② 전국 의과대학 IPE 프로그램 운영 현황에 대한 체계적 자료의 부재

국내 의과대학의 IPE 운영 사례가 개별 대학 수준에 산재하여, 어떤 형태의 프로그램이 어떤 대상·규모·방식으로 운영되고 있는지에 대한 전국 단위 자료가 축적되어 있지 않다. 역량 체계를 개발하더라도 현장 적용 가능성을 검토할 준거 사례가 없으면 실행으로 이어지기 어렵다. 본 과제는 전국 의과대학의 IPE 프로그램 사례를 취합하여 이 자료 기반을 마련하고자 하였다.

2. 주요 개념 및 용어 정의

용어	정의	출처
전문직 간 교육(Interprofessional Education, IPE)	둘 이상의 전문직 학생이 서로에 대해(about), 서로로부터(from), 서로와 함께(with) 학습하는 교육	WHO (2010)
전문직 간 협업(Interprofessional Collaboration, IPC)	서로 다른 전문직 배경을 가진 보건의료 종사자가 환자, 가족, 돌봄제공자, 지역 사회와 함께 최상의 건강 성과를 달성하기 위해 협력하는 실천	WHO (2010)
수정 델파이 조사	익명의 전문가 패널을 대상으로 구조화된 설문을 반복 시행하고, 라운드별 집단 통계 결과를 환류하여 합의를 형성하는 조사 방법	
명목집단기법(Nominal Group Technique, NGT)	연구팀이 1차 라운드 주관식 의견을 검토·정련하기 위해 사용한 구조화된 집단 의사결정 기법	

3. 선행연구 및 문헌 고찰

가. 문헌 검토 방법 및 범위

본 과제의 문헌 검토는 목적이 서로 다른 두 갈래로 수행하였다. 검색 전략과 포함·제외 기준은 아래와 같다.

구 분	내 용
검토의 성격	① 역량 프레임워크 검토 — 역량 체계 초안 구성을 위한 목적표집형 검토(purposive review). 역량 프레임워크는 학술 데이터베이스에 색인되지 않는 회색문헌(grey literature)으로 발간되므로 데이터베이스 검색, 발간 기관 웹사이트 직접 검색, 참고문헌 추적(snowballing)을 병행하였다. ② IPE 실행 현황 검토 — 교육과정 구축·운영 방법론과 국내 실행 현황에 관한 서술적 검토(narrative review)
데이터베이스	국외: PubMed/MEDLINE, ERIC / 국내: RISS, KISS, KoreaMed, DBpia
기관 웹사이트	IPEC(미국), CIHC(캐나다), CAIPE-CUILLU(영국), Curtin University(호주), 일본 IPE 관련 학회·대학, WHO, HPAC
검색어	국외: interprofessional education, interprofessional collaboration, IPE, core competency, competency framework, health professions education 국내: 전문직 간 교육, 전문직간교육, 전문직 간 협업, 다학제 교육, IPE, 핵심역량
검색 기간·시기	WHO 「Framework for Action」 발간연도(2010년) 이후 자료를 대상으로 2025년 10월~2026년 1월에 검색
포함 기준	역량 프레임워크: ㉠ 국가 또는 기관 단위 공식 발간, ㉡ 역량 영역 구분과 역량 진술문이 전문 공개, ㉢ 영어 또는 한국어 연구 문헌: ㉠ 보건의료계열 학부 학생 대상 IPE 연구, ㉡ 국내 실행 현황 조사·고찰연구, ㉢ 학술지 게재 논문
제외 기준	역량 프레임워크: 단일 프로그램 수준의 자체 역량 목록, 초록만 확인 가능한 자료, 동일 프레임워크의 구판(최신 개정판 우선) 연구 문헌: 졸업 후 교육(전공의·현직자) 대상 연구, 개별 프로그램의 단순 만족도 보고
검토 문헌 수	최종 검토 역량 프레임워크 5개국 5종, 추출·대조한 역량 진술문 총 192개 동향 문헌 국외 10편 / 국내 22편
자료 추출·검토 절차	연구팀이 각 프레임워크에서 역량 영역명·영역 정의·역량 진술문을 분담 추출하여 192개 진술문 데이터셋을 구성하고, 의미 단위로 분류·통합하여 1차 8개 영역으로 정리한 뒤, 제3차 회의(2026. 1. 21.)에서 연구팀 전원이 대조·검토하여 5개 영역으로 확정하였다.

나. IPE 핵심역량 프레임워크에 관한 선행연구

해외 주요 국가에서 개발·운영 중인 전문직 간 협업(IPC)·전문직 간 교육(IPE) 관련 역량 프레임워크를 검토하였다. 검토 대상은 미국, 캐나다, 영국, 호주, 일본 총 5개 국가의 프레임워크이다(IPEC, 2023; CIHC, 2024; CUILU, 2010; Haruta et al., 2018; Curtin University, 2013). 검토 결과, IPEC의 4개 영역 구조가 국제적 표준으로 기능하고 있으나, 성찰(reflection)의 위치에 대해서는 프레임워크 간 차이가 확인되었다. 미국, 캐나다, 영국은 성찰을 독립 영역으로 두지 않는 반면, 호주의 Curtin University와 일본 프레임워크는 이를 명시적 역량 영역으로 포함하고 있다. 본 과제는 이러한 검토를 근거로 IPEC 2023의 4개 영역과 대응 관계를 유지하면서 '자기성찰과 팀성찰'을 제5영역으로 독립 설정하는 구조를 채택하였다.

다. IPE 교육과정의 구축·운영 방법론에 관한 선행연구

North 등(2024)은 다기관 협력 기반 IPE 교육과정의 구축·유지·평가를 위한 프레임워크를 제시하였다. 이 프레임워크는 4단계로 구성된다: (1) 준거 정의(defining metrics) — 기관의 IPE 역량 체계 설정 및 측정 가능한 학습성과 수립, (2) 인벤토리 구축(building an inventory) — 기존 교육과정 내 IPE 활동 목록화 및 격차 분석, (3) 유지·확장(sustaining and growing) — IPE 활동의 질 관리와 프로그램 확장, (4) 교육과정 구조화(threading the curriculum) — IPE를 학년별 교육과정에 종적으로 편성. 이 프레임워크는 기관 차원의 교육과정 구축 절차를 체계화하였으나, 역량 자체의 도출은 IPEC 역량을 준용하는 것을 전제한다.

Health Professions Accreditors Collaborative(HPAC, 2019)는 '질 높은 IPE(quality IPE)'의 판정 준거를 제시하여, IPE가 단순한 다직종 접촉이 아닌 교육적으로 의미 있는 학습 경험이 되기 위한 조건을 규정하였다. 이 가이드라인은 IPE 프로그램의 설계·운영·평가 전반에 걸친 질 기준을 제공하며, 본 과제의 사례 조사 양식 설계에 참고하였다.

학습자 발달 수준에 따른 IPE 계열화(sequencing) 모형으로는 exposure–immersion–mastery(또는 integration) 단계 모형이 널리 활용된다. 이 모형은 저학년에서는 타 전문직에 대한 인식과 이해(exposure), 중간 단계에서는 협업 활동에의 적극적 참여(immersion), 졸업 학년에는 임상 현장에서의 협업 역량 적용(mastery/integration)으로 IPE 경험을 계열화한다. 본 과제의 사례 조사 양식에는 이 단계를 '학습 단계' 항목으로 반영하여, 각 대학의 IPE 프로그램이 학습자 발달 경로상 어느 위치에 해당하는지를 파악할 수 있도록 설계하였다.

라. 국내 연구 동향

국내 의과대학의 IPE 운영 현황에 관한 전국 단위 조사로는 박귀화 등(2022)의 연구가 있다. 이 연구는 전국 40개 의과대학·의학전문대학원을 대상으로 IPE 운영 여부, 참여 전공, 교육방법, 운영상 장애요인 및 교육 요구 등을 조사하였으며, 32개 대학이 응답하였다. 조사 결과 국내 의과대학에서 IPE를 운영하거나 시도한 사례가 확인되었으나, IPE가 모든 의과대학의 정규 교육과정에 보편적으로 정착한 단계는 아니었으며, 대학별 운영 수준과 형태에도 차이가 있었다. 다만 해당 조사는 응답 대학을 대상으로 한 결과이므로, 미응답 대학의 현황까지 포함한 전체 의과대학의 실태로 일반화하는 데에는 주의가 필요하다.

개별 프로그램 수준의 연구에서도 국내 IPE의 현황과 과제가 확인된다. 국내 IPE 프로그램은 특정 대학과 전공의 협력에 기반하여 단기간 또는 비교과 형태로 운영되는 경우가 많아, 입학부터 졸업까지 협업 역량을 단계적으로 발달시키는 종단적 교육과정으로 연결되기 어렵고, 대학별 프로그램의 교육목표와 성과를 비교하기도 쉽지 않다(박연철 등, 2024; 유지혜 & 박귀화, 2024). 또한 참여 전공이 의학과 간호학 등 일부 조합에 집중되는 경우가 많아, 지역사회 보건·의료·돌봄에서 요구되는 다양한 전문직 간 협업을 충분히 반영하지 못할 가능성이 있다. Lee 등(2024)이 국내 시뮬레이션 기반 IPE 연구를 분석한 범위 고찰에서도 유사한 경향이 확인된다. 분석 대상 10편의 연구는 대부분 의학과 간호학 학생의 협업을 다루었으며, 교육기간은 약 2시간에서 2주까지 다양하였고, 평가 역시 학습자의 반응·태도·지식·기술 등 비교적 단기적 성과에 집중되어 있었다.

이러한 국내 연구 동향은 본 과제의 필요성을 두 가지 측면에서 뒷받침한다. 첫째, 국내 맥락에 적합한 IPE 핵심역량 체계가 부재하여 각 대학이 자체적으로 역량을 설정하거나 해외 프레임워크를 차용하고 있다. 표준화된 역량 체계가 없는 상황에서는 대학 간 교육목표와 성과의 비교가 어렵고, 다양한 대학과 전문직이 공동으로 활용할 수 있는 모듈과 교수자용 운영자료의 축적도 제한된다. 본 과제에서 개발하는 역량 체계는 향후 대학별 참여 전공·대상 학년·학생 수·교육자원에 따라 조정 가능한 기본 설계안으로서의 IPE 모듈 개발의 준거로 기능할 수 있다. 둘째, 기존 전국 단위 조사(박귀화 등, 2022)는 설문 기반으로 수행되어 IPE 운영 여부와 전반적 현황을 파악하는 데 기여하였으나, 개별 프로그램의 구체적인 학습목표·교육활동·평가방법·운영 체계·성공요인 및 문제해결 과정을 심층적으로 파악하는 데에는 한계가 있었다. 조사 이후 각 대학에서 새롭게 도입되거나 변경된 프로그램을 반영하는 정기적 자료 갱신 체계도 마련되어 있지 않다. 본 과제의 사례 취합은 확정된 역량 체계를 매핑 준거로 포함한 조사 양식을 사용하여, 프로그램 수준의 상세 정보를 체계적으로 수집하고 역량 체계의 현장 적용 가능성을 함께 검토하고자 한다.

마. 선행연구의 한계와 본 과제의 차별성

국제 역량 프레임워크(IPEC, CIHC, Curtin 대학 등)는 4개 영역 중심으로 구성되어 성찰(reflection)을 독립 영역으로 두지 않거나(IPEC), 국내 의과대학 학제·현장 맥락을 반영하지 않는다. 본 과제는 IPEC 2023과의 대응 관계를 유지하면서 '자기성찰과 팀성찰'을 제5영역으로 독립시켜, 국제 비교가능성과 국내 적용성을 동시에 확보하였다.

North 등(2024)의 프레임워크는 개별 기관(단일 대학) 내부의 교육과정 구축 절차를 다루며, 역량 자체를 도출하는 절차는 IPEC 역량을 준용하는 것으로 전제한다. 본 과제는 국내 맥락에 적합한 역량 체계를 다전문직 전문가 델파이로 직접 도출하고, 전국 의과대학의 프로그램 사례를 취합하였다. North 등이 제시한 '준거 정의 → 인벤토리 구축 → 유지·확장 → 교육과정 구조화'의 순서는 본 과제 2차년도 추진 방향 설정에 참고할 수 있다.

Exposure–Immersion–Mastery 계열화 모형(Charles et al., 2010)은 학습자의 전문직 정체성 발달 단계에 따라 IPE 경험의 유형과 시기를 배치하는 유용한 틀을 제공하지만, 원래 모형은 보건·휴먼서비스 전 직종의 학생과 졸업 후 실무자를 포괄하는 범용 모형으로 개발되었다. 따라서 의학교육 학제 내에서 어느 시점에 각 단계를 배치할 것인지에 대한 구체적 지침은 제시하지 않는다. 본 과제는 이 모형을 기본의학교육(Basic Medical Education, BME) 과정으로 한정하여 적용하였다. 사례 조사 양식의 '학습 단계' 항목에서 Exposure-Immersion-Integration 각 단계를 BME 학년 구조에 대응시킴으로써, 의과대학 교육과정 내에서 IPE 경험이 학습자 발달 경로상 어느 위치에 배치되어 있는지를 파악할 수 있도록 설계하였다.

4. 국내외 사례 분석

구분	기관·대학(국가)	주요 운영 내용	시사점
국외	IPEC (미국)	Values/Ethics, Roles/Responsibilities, Interprofessional Communication, Teams and Teamwork의 4개 영역, 33개 하위역량으로 구성된 핵심역량 체계(Version 3, 2023)	국제적으로 가장 널리 활용되는 프레임워크로, 본 과제의 1~4영역 구조 설계 시 대응 관계 확보의 준거로 활용
국외	CIHC (캐나다)	Interprofessional Communication, Patient/Client/Family/Community-Centred Care, Role Clarification, Team Functioning, Collaborative Leadership, Interprofessional Conflict Resolution의 6개 영역으로 구성	갈등 해결과 협업적 리더십을 독립 영역으로 설정하여 팀 역동 관련 역량의 세분화 사례 제공
국외	Curtin University (호주)	Communication, Teamwork, Role Clarification, Reflection의 4개 영역, 역량 기반 교육과정과 직접 연계한 프레임워크 운영	성찰(Reflection)을 독립 영역으로 설정한 사례로, 본 과제의 제5영역('자기성찰과 팀성찰') 설정의 근거
국외	일본	IPE를 보건의료계열 학부 교육과정에 종적으로 편성하고, 성찰을 핵심 역량으로 포함한 프레임워크 운영	아시아 맥락에서 성찰을 강조한 사례로, 한국적 맥락에서의 성찰 역량 설정 근거 보강
국외	University of British Columbia (캐나다)	15개 보건·휴먼서비스 프로그램이 참여하는 IPE 교육과정을 Exposure–Immersion–Mastery 3단계 모형으로 구조화. Valsiner의 발달이론과 Mezirow의 전환학습이론에 기반하여, 학습자의 전문직 정체성 발달 단계에 따라 IPE 경험의 유형과 시기를 배치	본 과제의 사례 조사 양식에 적용한 '학습 단계 (Exposure/Immersion/Integration)' 항목의 이론적 원형을 제공. 전문직 정체성 형성 수준에 따라 IPE 경험을 계열화해야 한다는 설계 원칙의 근거
국외	University of Minnesota · Creighton University · Thomas Jefferson University (미국)	3개 대학이 공동으로 기관 수준 IPE 교육과정의 구축·유지·평가를 위한 4단계 프레임워크를 제시: ① 질 높은 IPE 판정 준거 정의, ② IPE 활동 인벤토리 구축, ③ 유지·확장, ④ 교육과정 구조화	본 과제의 '준거 정의(역량 체계 개발) → 인벤토리 구축(사례 취합)' 순서가 이 프레임워크의 ①→② 단계와 부합. 2차년도 '질 높은 IPE' 판정 준거 개발 시 참조할 기준 항목을 제공

5. 시사점 및 과제 설계 방향

도출된 시사점	과제 설계 반영 내용
① 국제 프레임워크와의 비교가능성 확보가 필요하다	역량 영역명을 IPEC 2023의 4개 영역과 대응하도록 유지 (변경대비표 비교 참조)
② 한국의 의학교육 맥락에서는 성찰 역량이 별도로 강조될 필요가 있다	호주와 일본 프레임워크를 근거로 '자기성찰과 팀성찰'을 제5영역으로 독립 설정
③ 다전문직·다기관 전문가의 합의가 필요하다	의학·간호·약학·사회복지·병원 소속 전문가로 델파이패널 구성, 2라운드 델파이 시행
④ 역량 체계만으로는 교육과정 실행으로 이어지지 않으며, 기존 운영 활동의 목록화가 병행되어야 한다	역량 체계 개발과 전국 의과대학 IPE 프로그램 사례 취합을 1차년도에 병행 추진하여, 역량 체계의 현장 적용 기반을 함께 확보
⑤ 학습자 발달 수준에 따른 마일스톤, 활동 계열화가 필요하다 (exposure-immersion-mastery 등)	1차년도에는 역량 진술문 확정에 집중하고, 학년·교육단계별 도달 수준(마일스톤) 설정과 그에 따른 프로그램 모듈은 2차년도 과제로 배치. 프로그램 사례 취합시 학습자 단계를 체크할 수 있도록 함.

02 과제 목표 및 성과지표

1. 최종 목표 및 1차년도 목표

구 분	내 용
최종 목표 (사업 종료 시점)	국내 의과대학생 및 보건의료전공계열 학생을 위한 IPE 핵심역량 체계와 이에 기반한 IPE 프로그램 모형을 개발하고, 전국 의과대학 이 IPE 프로그램을 실행할 수 있도록 지원한다.
1차년도 목표	① 국내 의과대학생 및 보건의료전공계열 학생을 위한 IPE 핵심역량 체계를 개발한다. 다전문직 전문가 합의를 통해 역량 영역과 역량 진술문을 도출·확정한다. ② 전국 의과대학의 IPE 프로그램 운영 사례를 취합한다. 국내 IPE 실행 현황을 파악하고, 이를 기반으로 표준안을 제공하여 역량 체계의 현장 적용을 위한 기초자료를 확보한다.
과제 범위 (포함·제외)	포함 [과제 1] 역량 영역 설정, 역량 진술문 개발·정련·전문가 합의, 영역 정의문 개발 [과제 1-2] IPE 프로그램 시범 운영 [과제 2] 전국 의과대학 IPE 프로그램 운영 사례 취합 및 정리 [과제 3] 역량 체계 및 프로그램 성과 확산 제외 교육모듈·콘텐츠 개발, 평가도구(루브릭) 개발, 학년별 도달 수준(마일스톤) 설정

2. 성과지표 및 목표치

연번	성과지표명	유형	산출식·측정 방법	목표	실적	달성률(%)
1	공동 IPE 모듈 개발 여부	정량	협회 주관으로 공동 개발된 표준형 IPE 모듈(예: 시뮬레이션, 온라인, 케이스 기반) 여부	Y1에 개발	역량 체계 개발, 프로그램 사례 취합 중	30%
2	참여 의과대학 비율	정량	IPE 기반 프로그램 개발·운영에 참여한 의과대학의 비율	Y1 목표 없음, Y2 10%, Y3 20/5	해당 없음	-
3	교원 역량강화 연수 참여율	정량	KAMC에서 주관하는 IPE 교수역량강화 워크숍·연수 여부	Y1~Y3에 Y	1회, 총 13개 대학 교수 20인 참석	100%
4	우수사례 도출 및 공유 여부	정량	참여 대학 중 우수 운영사례를 발굴 또는 공유 여부	Y1 목표 없음, Y2~3에 해당	해당 없음	-

03 추진 체계 및 방법

1. 추진 체계 및 조직

조직·회의체	구성(인원)	주요 기능 및 개최 주기
교원 대상 워크숍	전국 의과대학, 간호대학, 약학대학, 사회복지대학 소속 교수(20명)	IPE 프로그램 개발 및 역량 강화 (1회)
델파이 전문가 패널	전국 의과대학·병원, 간호대학, 약학대학, 사회복지학대학 소속 교수(19명)	역량 진술문 내용 타당도 점검(1회), 역량 영역및 역량 진술문 적절성 평정 및 주관식 의견 제시(2회)

2. 참여 대학·기관 현황

참여 형태	대학·기관 (담당자)	기관 수
회의·워크숍·델파이	가톨릭관동대학교 의과대학(박영순·이상엽), 건국대학교 의과대학(김강문), 건양대학교 의과대학(천경희), 경북대학교 의과대학(여상희·정민규), 대구가톨릭대학교 의과대학(오희진), 충남대학교 의과대학(이소영), 계명대학교 의과대학(김재범), 경희대학교 의과대학(최효선), 울산대학교 의과대학(김은기), 차의과학대학교 의학전문대학원(최재정), 서울아산병원(채보라)	10
회의·워크숍·시범운영	아주대학교 의과대학(유지혜·김세진)	1
합계	의과대학·의학전문대학원 11개교, 동반 보건의료계열 대학 6개교	17

3. 연구·개발 방법

방법	대상·표본	실시 시기	분석 방법·활용
문헌고찰	해외 5개국 프레임워크	2025. 10 ~ 2026. 1	해외 프레임워크 검토 영역 구조 및 진술문 초안 도출, 방법론 설정(수정 델파이 및 NGT)
내용타당도 검증	전문가 12명	2026. 3. 22.~3. 30.	온라인 설문, 4점 적절성 척도. 검증 대상 31개 항목(기본 원칙 2 + 영역 정의 5 + 하위 역량 24). 결과: CVR 0.83~1.00, I-CVI 0.92~1.00으로 31개 전 항목 기준 충족. 주관식 의견은 진술문 수정 근거로 활용
합의회의	연구팀	2026. 3. 5 2026. 6. 15.	역량 체계 검토·확정 및 졸업성과 매칭 1차 주관식 의견을 반영하여 진술문 통합·이동·수정
델파이 조사	전문가 패널 19명	1차: 2026. 5. 20.~6. 5. 2차: 2026. 7. 6.~7. 12.	온라인 설문(Google Forms), 5점 Likert 척도. 합의 기준: 중앙값 ≥ 4.0 , 합의율 $\geq 75\%$, CV ≤ 0.50 , IQR ≤ 1.0 . 주관식 의견은 문항별로 분류하여 진술문 수정 근거로 활용
워크숍	전국 의과대학, 간호대학, 약학대학, 사회 복지대학 교수 총 21인	워크숍 2026. 3. 5.~3. 6.(2세션)	
시범운영	아주대학교 의과대학, 간호대학, 화성의 과학대학 학생 60명	2026. 6. 22.	자기보고식 평가로 역량 수준 사전-사후 분석, 프로그램 사후 만족도 및 성찰 분석
기타(사례 조사)	전국 의과대학 IPE 프로그램 설계·운영 사례		

4. 연구윤리

구 분	내 용
IRB 심의 여부	☒ 승인 (기관: 아주대학교병원 임상연구윤리센터, 승인번호: AJOUIRB-SB-2026-339, 승인일: 2026-06-29) ☐ 심의면제 ☐ 해당없음
개인정보 보호 조치	응답 자료는 연구 목적으로만 사용하였으며, 분석·보고 시 응답자명을 제외하고 처리하였다. 개별 응답 증빙자료는 별도 파일로 관리한다.
저작권·초상권 확인	

5. 추진 일정

단계	기간	주요 활동	단계별 산출물
1단계	2025. 10 ~ 2026. 1	국내외 IPE 역량 프레임워크 문헌고찰, 역량 체계 초안 구성	
2단계	2025. 10.~2026. 3.	대학 IPE 운영 사례 공유 세미나 2회, 제3차 회의(역량 영역 확정)	5개 역량 영역·24개 진술문, 졸업성과 매칭표, 내용 타당도 검증 결과, 1차 델파이 문항
3단계	2026. 3. 23 ~ 3.30	IPE 역량 체계 내용타당도 검증	
4단계	2026. 5. 20.~ 6. 5.	델파이 1차 라운드 실시 및 분석	1차 라운드 분석결과, 문항별 주관식 의견 정리자료
5단계	2026. 6.15	NGT를 통한 진술문 정련(24개 → 20개), 2차 라운드 설계	2라운드 설계자료, 2차 델파이 설문지
6단계	2026. 7. 6.~7. 31.	델파이 2차 라운드 실시·분석, 역량 진술문 변경대비표 작성, 최종 역량 체계 확정	2차 라운드 분석결과, 변경대비표, IPE 핵심역량 체계(5영역 20진술문) 확정본
(예정)	2026. 8.	① 결과 정리 및 최종보고서 작성, 산출물 정리 ② 전국 의과대학 IPE 프로그램 사례 취합 착수 (조사서식 개발 → 자료 요청)	1차년도 최종보고서 IPE 프로그램 사례 조사서식

04 추진 경과 및 실적

1. 단계별 추진 경과

가. 과제 착수 및 국내 IPE 운영 사례 공유 (2025. 10.~12.)

제1차 온라인 세미나(2025. 10. 25.)에서 가톨릭관동의대와 건양의대의 IPE 운영 사례를 공유하고, 공유대학(K-MedU)에 탑재할 IPE 모듈 개발 방향을 논의하였다. 제2차 온라인 세미나(2025. 12. 19.)에서는 계명의대가 2021년 파일럿부터 2023년 정식 교과 전환(간호대 2학점·의대 1학점, 총 20시간)에 이르는 5년간의 운영 경험을 공유하였다. 아울러 수정 사업계획서를 기준으로 3-3 IPE를 세부과제로 계획한 대학이 8개교임을 확인하고, 연구팀 참여 대학의 계획 내용을 공유하기로 하였다. 이 단계에서 확인된 현장 쟁점은 ① 학사일정 조율, ② 반복 운영에 따른 교수 부담, ③ 정규 교과 전환 이후 참여 교수에 대한 리워드 축소 등의 문제가 논의되었다.

나. 역량 영역 도출 및 한국적 맥락 분석 (2026. 1.)

제3차 회의(2026. 1. 21., 경북의대)에서 해외 IPE 핵심역량 프레임워크를 검토하였다. 6개국 192개 역량을 통합하여 8개 영역으로 정리한 뒤, 최종적으로 5개 영역(윤리와 가치, 역할과 책임, 전문직 간 의사소통, 팀워크와 리더십, 자기성찰과 팀성찰)으로 확정하였다. 이 과정에서 다음 세 가지 설계 원칙이 결정되었다: ① '환자 및 보호자 중심'은 개별 역량이 아닌 중심 핵심영역으로, '보건의료시스템 질 향상'은 최외곽 핵심영역으로 배치한다. ② IPE 역량을 독립적으로 신설하지 않고 '한국의 의사상' 및 졸업성과와 매칭하여, 각 대학이 기존 교육과정 안에서 수용하기 쉬운 형태로 제시한다. ③ 전문직 범위를 3차로 구분하되(1차 의사-간호사 / 2차 원내 보건의료직종 / 3차 행정·지역사회 직종), 현실적으로 2차 범위까지를 프로그램 개발 목표로 한다.

한국적 맥락으로는 초고령 사회 진입, 지역사회 통합돌봄 정책 시행, 보건의료-사회복지 체계의 분절성, 위계적 의료문화 등이 확인되었으며, 이는 역량 자체보다 시나리오·사례 개발의 배경으로 활용하기로 하였다.

다. 워크숍 (2026. 3. 5.)

제4차 회의(대전 인터시티 호텔)에서 환자중심과 보건의료시스템 질 향상을 기본 원칙으로 설정하고, 5개 영역의 정의를 확인한 뒤 총 24개 하위 역량을 도출하였다(윤리와 가치 4 / 역할과 책임 5 / 전문직 간 의사소통 5 / 팀워크와 리더십 7 / 자기성찰과 팀성찰 3). 아울러 KAMC 기본의학교육 졸업성과 제2판(2026)과의 매칭을 수행하여, 개발 역량이 기존 졸업성과 체계와 정합적으로 연결되도록 하였다. 차기 계획으로 내용타당도 검증 시행과 제2차 성과공유세미나 보고를 결정하였다. 이처럼 IPE 운영을 위한 역량을 정의하고 IPE를 위한 협력 네트워크 구성과 운영방안을 논의하였으며, IPE 프로그램 체험을 시행하였다.

라. 교원 역량 강화를 위한 워크숍 개최 (2026. 3. 6.)

워크숍(2026. 3. 6. 금, 11:00~17:30, 참석 26명)은 IPE 프로그램 체험, IPE 경험 공유(강의), IPE 프로그램 개발, 개발 프로그램 공유 및 평가 순으로 진행되었다. 8개 팀(가톨릭관동·건양·경북대·대구가톨릭·울산·아주·충남·차의전원)이 'IPE 프로그램 개발하기' 산출물을 작성하고 상호 평가하였다.

마. 내용타당도 검증 및 성과 공유 (2026. 3. 24.~3. 30.)

집중 워크숍(제4차)에서 도출한 역량 체계에 대해 전문가 12명을 대상으로 내용타당도 검증을 시행하였다(2026. 3. 24.~3. 28., 4점 척도). 검증 대상은 기본 원칙 2개, 역량 영역 정의 5개, 하위 역량 진술문 24개 등 총 31개 항목이었다. 검증 결과, 31개 전 항목이 내용타당도 기준을 충족하였다(CVR 0.83~1.00, I-CVI 0.92~1.00). CVR이 0.83으로 상대적으로 낮은 항목은 6개(1.4, 3.3, 3.4, 4.2, 4.6, 4.7)로, 모두 12명 중 1명이 '부적절'로 평정한 경우이다.

정량 결과와 별개로 자유기술 의견에서는 ① 정의에 '이해하고', '존중하며', '성찰하고' 등 추상적 표현이 포함되어 측정 가능성이 낮다는 지적, ② 리더십뿐 아니라 팔로워십 개념이 드러나는 하위 역량이 필요하다는 지적, ③ 환자·보호자·가족·지역사회를 보건의료팀의 핵심 파트너로 인식하는 관점이 필요하다는 지적 등이 제기되었다. 정량 지표상으로는 전 항목이 기준을 충족하였으나 질적 의견에서 표현·구성 문제가 다수 확인되었으며, 이를 반영하여 델파이 1차 문항을 확정하였다. 검증 결과는 2026. 3. 30. 제2회 성과공유세미나에서 「역량에서 교육과정으로 - IPE」로 보고하였다.

바. 델파이 1차 라운드 (2026. 5. 20.~6. 5.)

5개 영역 24개 진술문에 대해 전문가 18명이 응답하였다. 전 24문항이 합의 기준을 충족하였다(중앙값 4.0~5.0, 합의율 83.3~100%, CV 0.049~0.175). 다만 주관식 의견에서 ① 진술문 간 중복(구 1.2와 2.2, 구 2.5와 2.2, 구 3.3~3.5), ② 영역 부적합(구 2.4는 의사소통 역량), ③ 이중진술 및 관찰 불가 서술어, ④ 척도 불일치(구 5.3은 4점 척도로 평정됨) 문제가 제기되었다.

사. 진술문 정련 및 2차 라운드 설계 (2026. 6. 15., 제5차 회의)

대구가톨릭대학교 루가관에서 제5차 회의를 개최하여 1차 라운드 결과를 공유하고, 명목집단기법(NGT)으로 주관식 의견을 검토·반영하였다(통합: 구 2.5 → 2.1.2.2 / 영역 이동: 구 2.4 → ③영역 / 분리·통합: 구 3.4 → 3.3 등 / 재평정: 5.3을 4점→5점 척도 / 표현 수정·구체화: 다수 문항). 그 결과 1차 라운드 진술문이 2차 라운드에서 20개로 재조정되었다.

아. 델파이 2차 라운드 및 최종 확정 (2026. 7.)

수정된 20개 진술문에 대해 1차 라운드 통계 결과와 수정 사유를 함께 제시한 뒤, 전문가 18명에게 5점 척도 평정을 요청하였다(응답 기간 2026. 7. 6.~7. 12.). 전 20문항이 합의 기준을 충족하였다(전 문항 중앙값 5.0, 합의율 83.3~100%, CV 0.00~0.18). 2차 주관식 의견을 반영하여 역량 진술문 변경대비표를 작성하고 최종 수정안을 확정하였다.

자. 전국 의과대학 IPE 프로그램 사례 취합 - 조사 양식 개발 완료, 자료 취합 미착수

1차년도 목표 ②는 개발된 IPE 핵심역량 체계를 준거로 전국 의과대학의 IPE 프로그램 운영 현황을 취합하는 것이다. 따라서 역량 체계 확정이 선행되어야 하며, 실제 자료 취합은 그 이후 단계에 해당한다. 진행 상황: ① 조사 양식 개발(완료, 제5차 회의에서 확정), ② 양식 검증(완료, 예시 사례 1건 작성), ③ 전국 의과대학 대상 자료 요청(미착수, 1차년도 잔여기간 내 착수 예정), ④ 취합·유형 분류 및 사례집 편집(미착수), ⑤ 역량 체계 정합성 검토·환류(미착수).

개발된 조사 양식은 단순 현황 조사표가 아니라 확정된 20개 역량 진술문을 매핑 항목으로 포함하고 있어, 취합 결과가 곧 역량 체계의 현장 정합성 검토 자료로 기능하도록 설계되었다. 이는 North 등(2024)이 제시한 '준거 정의 → 인벤토리 구축' 순서와 부합한다.

2. 회의·워크숍·세미나 개최 실적

가. 개최 실적 총괄

내부 워크숍	1회	14명	IPE 프로그램 체험 및 역량 체계 논의	2026. 3. 5 (14명)
외부 워크숍	1회	26명	역량 강화, IPE 프로그램 개발 실습	2026. 3. 6., 대전 인터시티 호텔
연구회의(전문가 회의)	2회	37명	역량 체계 검토, 델파이 결과 분석 및 진술문 정련(NGT), 회의	2026. 1. 21 (12명)2026. 6. 15 (11명)
실무진 회의				—
세미나	2회	29명	대학 IPE 운영 사례 공유	2025. 10. 25 (8명) 2025. 12. 19 (11명),
설명회	1회		사업 성과 대외 공유	제2회 성과공유세미나(2026. 3. 30)
합 계	7회			

나. 회차별 세부 실적

회차별 세부 실적(연번·구분·일자·장소·주요 안건·논의 및 결정 사항)은 양식의 안내에 따라 부록 2로 이관하고, 본문에는 위 개최 실적 총괄표를 제시한다. 각 회차의 의사결정 흐름은 앞의 1절 「단계별 추진 경과」에 서술하였다.

3. 조사·시범운영 추진 실적

구분	대상	규모(N)	실시 결과 요약
내용 타당도 조사	다전문직 전문가 패널	12	기본 원칙 및 5개 영역 정의·하위 역량에 대한 질적 의견 수렴, 1차 델파이 문항 확정에 반영
델파이 1차 라운드	다전문직 전문가 패널	19	5개 영역 24개 진술문 전 문항 합의 기준 충족(중앙값 4.0~5.0, 합의율 83.3~100%, CV ≤ 0.175)
델파이 2차 라운드	다전문직 전문가 패널	18	5개 영역 20개 진술문 전 문항 합의 기준 충족(중앙값 5.0, 합의율 83.3~100%, CV 0.00~0.18)
전문가 워크숍	의과대학·의전원 및 동반 간호·약학·의료사회 복지 대학 소속 전문가	20	역량 강화 교육 시행, 8개 팀 IPE 프로그램 개발 산출물 작성
IPE 프로그램 사례 취합	전국 의과대학	–	진행 예정 (1차년도 잔여기간 내 착수 예정)
시범운영	연구팀 소속 대학	59	의과대학, 간호대학, 의료사회복지학과 학생 59명 대상 운영. 역량 향상에 유의한 차이 확인

4. 계획 대비 변경사항 및 사유

변경 항목	당초 계획	변경 내용	변경 사유
전국 IPE 프로그램 사례 취합	1차년도 내 자료 취합 및 사례집 발간 완료	조사 양식 개발까지 완료, 자료 요청은 1차년도 잔여기간 착수 및 2차년도 초 완료	사례 취합은 확정된 역량 체계를 매핑 준거로 사용하므로 역량 체계 확정(2026. 7.)이 선행되어야 함
공통 IPE 모듈 개발	1차년도 내 표준형 모듈 개발	2차년도로 이월	제3차 회의에서 역량 도출을 선행 과제로 결정. 모듈 설계에는 목표 역량과 설계 준거의 확보가 선행 요건

05 주요 결과 및 성과물

1. 핵심 결과 요약

국내 의과대학생 및 보건의료전공계열 학생을 위한 IPE 핵심역량 체계를 5개 역량영역·20개 역량 진술문으로 확정하였다.

① 윤리와 가치 (4개), ② 역할과 책임 (4개), ③ 전문직 간 의사소통 (3개), ④ 팀워크와 리더십 (6개), ⑤ 자기성찰과 팀성찰 (3개)

국제 프레임워크와의 대응 관계를 확보하면서 국내 맥락을 반영하였다. 1~4영역은 IPEC 2023의 4개 영역과 1:1 대응하며, 호주 및 일본 프레임워크를 근거로 '자기성찰과 팀성찰'을 제5영역으로 독립 설정하였다.

확정된 20개 역량 진술문을 매핑 항목으로 포함한 IPE 프로그램 설계·운영 사례 조사 양식을 개발하고, 적용 예시 사례 3건으로 실효성을 확인하였다. 사례 취합이 단순 현황 수집이 아니라 역량 반영 수준을 판정할 수 있는 조사로 설계되었다. 전국 대상 자료 취합은 1차년도 잔여기간 내 착수 예정이다.

개발된 역량 체계를 KAMC 기본의학교육 졸업성과 제2판(2026)과 매칭하였다. 이로써 각 대학이 IPE 역량을 별도 체계로 신설하지 않고 기존 졸업성과 안에서 수용할 수 있는 경로를 확보하였다.

2. 산출물 총괄표

연번	산출물명	유형	규격·분량	완료 시점	완료 여부	첨부 위치
1	IPE 핵심역량 체계(5개 영역·20개 역량 진술문)	역량·성과 체계(프레임)	5영역 20진술문	2026. 7.	완료	부록 1
2	IPE 프로그램 설계·운영 사례 조사 양식	표준양식·서식		2026. 6.	완료	부록 1
3	전국 의과대학 IPE프로그램 설계·운영 사례 조사 보고서	사례집		2026. 8	예정	부록 3

3. 산출물별 상세 내용

산출물 ① IPE 핵심역량 체계 (5개 영역·20개 역량 진술문)

항 목	내 용
산출물명	전문직 간 교육(IPE) 핵심역량 체계
개발 목적·활용 대상	IPE 교육과정을 설계·운영·평가할 때 준거로 삼을 공통 역량 체계 제공. 대상 학습자: 의과대학생 및 보건의료전공계열 학생 직접 활용 대상: 전국 의과대학 교육과정 담당 부서, IPE 운영 교수, 공동 운영 보건의료계열 대학 ※ 본 과제는 의과대학 교육혁신 지원사업의 개별과제로, 일차적 적용 맥락은 국내 의과대학의 IPE 교육과정이다.
개발 절차	① 국내외 IPE 역량 프레임워크 문헌고찰 → ② 5개 영역·진술문 초안 구성 → ③ 내용타당도 조사 → ④ NGT를 통한 진술문 정련 → ⑤ 델파이 1차 라운드 → ⑥ NGT를 통한 진술문 정련 → ⑦ 델파이 2차 라운드 → ⑧ 최종안 확정
주요 구성·목차	기본원칙2 - 환자중심, 보건의료시스템 질 향상 역량영역5 - 1. 윤리와 가치(1.1~1.4) / 2. 역할과 책임(2.1~2.4) / 3. 전문직 간 의사소통(3.1~3.3) / 4. 팀워크와 리더십(4.1~4.6) / 5. 자기성찰과 팀성찰(5.1~5.3) - 영역별 정의문 및 역량 진술문으로 구성
타당화·검증 근거	① 내용타당도 검증(2026. 3., N=12) — 31개 항목(기본원칙 2·영역정의 5·하위역량 24)에 대해 CVR 0.83~1.00, I-CVI 0.92~1.00으로 전 항목이 기준(CVR ≥ 0.56, I-CVI ≥ 0.78)을 충족 ② 2라운드 델파이 합의(N=19) — 2차 라운드 20문항 전부 중앙값 5.0, 합의율 83.3~100%(19문항이 88.9% 이상), CV 0.00~0.18로 사전 설정 합의 기준(중앙값 ≥ 4.0, 합의율 ≥ 75%, CV ≤ 0.50, IQR ≤ 1.0)을 모두 충족 ③ 패널 구성 - 의학·간호·약학·사회복지·병원 소속 다전문직 19명, 11년 이상 경력자 66.7%, IPE 경험 보유 88.9% ④ 기존 체계와의 정합성 - KAMC 기본의학교육 졸업성과 제2판(2026)과 매칭 수행
활용 방법 및 배포 계획	
한계 및 보완 필요사항	① 학습자 수준(시기)별 학습성과 제시 필요 ② 학생 대상 타당도·신뢰도 검증 및 평가도구 개발

산출물 ② IPE 프로그램 설계·운영 사례 조사 양식

항 목	내 용
산출물명	IPE 프로그램 설계·운영 사례 조사 양식
개발 목적·활용 대상	전국 의과대학의 IPE 프로그램 설계·운영 사례를 공통 양식으로 취합하여, ① 국내 IPE 실행 현황의 체계적 파악, ② 개발된 IPE 핵심역량 체계(5개 영역·20개 역량 진술문)와 각 대학 프로그램의 정합성 검토, ③ 대학 간 운영 모형 비교·공유를 위한 기초자료 확보를 목적으로 한다. 활용 대상: 전국 의과대학 IPE 담당 교수 및 교육과정 담당 부서, KAMC 교육혁신 지원사업팀
개발 절차	① 제3차 회의(2026. 1.)에서 사례 취합 필요성 합의 → ② 선행연구 검토를 통한 조사 항목 도출 → ③ 제5차 회의(2026. 6. 15.)에서 양식 초안 논의 및 확정 → ④ 연구팀 내 적용 예시 사례 3건 작성을 통한 양식 실효성 검증 → ⑤ 양식 확정
타당화·검증 근거	① 연구팀 내 적용 예시 사례 3건 작성을 통해 양식의 기재 가능성, 항목 누락 여부, 작성 부담 수준을 확인하였다. ② 양식의 C-3 역량 매핑표는 델파이 2차 라운드에서 확정된 20개 역량 진술문을 그대로 반영하여, 사례 취합 결과가 역량 체계와 직접 대응되도록 설계하였다. ③ 제5차 회의(2026. 6. 15.)에서 연구팀 전원의 검토를 거쳐 항목 구성과 기재 방식을 확정하였다.
활용 방법 및 배포 계획	① 1차년도 잔여기간(~2026. 8. 31.) 내 전국 의과대학(40개교) 대상으로 양식을 배포하고 IPE 프로그램 운영 사례 자료를 요청한다. ② 회신된 사례를 유형별로 분류하고 역량 매핑 현황을 정리하여 「전국 의과대학 IPE 프로그램 사례집」으로 편집한다. ③ 2차년도에는 취합 결과를 토대로 역량 체계의 현장 정합성을 검토하고, 우수 운영 사례를 발굴하여 운영 모형 도출의 입력자료로 활용한다.
한계 및 보완 필요사항	① 양식의 실효성 검증이 연구팀 내 3건의 적용 예시에 한정되어, 다양한 운영 형태(비교과, 온라인, 지역사회 기반 등)에 대한 기재 적합성은 실제 취합 과정에서 추가 확인이 필요하다. ② 양식 분량이 상당하여(A~I 섹션) 응답 대학의 작성 부담이 클 수 있으므로, 자료 요청 시 필수/선택 항목을 구분하거나 작성 가이드를 함께 배포하는 방안을 검토할 필요가 있다.

산출물 ③ 전국 의과대학 IPE 프로그램 사례집 (예정 — 미착수)

항 목	내 용
산출물명	전국 의과대학 IPE 프로그램 사례집
개발 목적·활용 대상	국내 의과대학의 IPE 운영 현황을 체계적으로 파악하여, 개발된 역량 체계의 현장 적용 가능성을 검토하고 대학 간 운영 모형을 공유한다.
개발 절차	① 조사 양식 개발 → ② 전국 의과대학 대상 자료 요청 → ③ 회신 자료 취합·정리 → ④ 확정된 IPE 핵심역량 체계에 비추어 역량 반영 수준 검토 → ⑤ 유형 분류 및 사례집 편집
주요 구성·목차	사례별 기술 항목: 프로그램명, 대상 학년·학과, 참여 전문직, 운영 형태(정규 교과/비교과), 교육방법, 시수, 평가방법, 담당 조직
타당화·검증 근거	해당 없음
활용 방법 및 배포 계획	
한계 및 보완 필요사항	1차년도 내 완료 여부가 회신률에 좌우되므로, 미회신 대학에 대한 후속 조치와 2차년도 이월 여부를 사전에 정해 둘 필요가 있다.

4. 시범운영 결과

구 분	내 용
시범운영 대학·대상	아주대학교 의과대학, 아주대학교 간호대학, 화성 의과학대학 사회복지학과 1-2학년 총 59명
운영 기간·규모	일시·장소: 2026. 6. 22.(월) 10:00~16:00, 총 6시간 / 수원컨벤션센터 규모: 3개 기관 3개 직종(의학·간호학·의료사회복지학) 1~2학년, 계획 60명(직종별 20명) 중 59명 참여 팀 편성: 팀당 6명(의학 2·간호 2·의료사회복지 2) 직종 균형 무작위 배정, 총 10팀 공동 교수진 7명(의과대학 3, 간호대학 2, 화성 의과학대학 2)이 퍼실리테이터·디브리퍼로 참여
운영 방식	유형: 비교과 대면 프로그램 / 개발모델 Starter Model(최소 자원형) / 학습 단계 노출(Exposure) / 수업모델 Case-based 주제: 「독거노인 일상 복귀를 위한 통합 케어 설계」 — 초고령사회 진입에 따른 지역사회 통합돌봄을 의학·간호·사회복지 3개 직종이 함께 다루는 사례 진행: 오리엔테이션·아이스브레이킹(70분) → 사전강의 및 사례 영상(30분) → 워크시트 STEP 1~2 개인 정보탐색·팀 통합(40분) → STEP 3~4 핵심과제 우선순위·역할 및 협업행동 수립(100분) → 갤러리 워크(50분) → 팀 발표 및 디브리핑(20분) → 사후 설문·성찰(10분) → 수료식·시상 목표 역량: 주도역량 1.4, 4.1 / 보조역량 2.2, 5.1, 5.3 디브리핑: 직종별 디브리핑(20분, 각 기관 담당 교수) 및 전체 디브리핑(5분, 3개 기관 운영팀)
정량 결과	측정도구: ICCAS(5점, 20문항), SPICE-R(5점, 10문항), 협업 역량(6점, 4문항)은 사전-사후 분석, 만족도(5점, 5문항) 사후 분석. 사전-사후 분석 결과 모든 항목에서 유의한 차이 확인. 만족도 평균 4.24
정성 결과	주관식 성찰 4문항에 대한 응답을 수집하여 주제별 키워드로 분석하였다. 학생 개선 의견: ① 활동 시간 부족(1순위) ② 참여 전공 확대 요구 운영상 확인된 장애요인: ① 3개 기관 간 학사일정 상이 ② 타 기관 학생 간 첫 대면에 따른 친밀도 부족과 직종별 용어 차이.
본 과제 산출물에 반영한 사항	① 확정된 20개 역량 진술문을 목표 역량 설정과 활동-역량 매핑에 그대로 적용하여, 역량 체계가 실제 프로그램 설계 언어로 작동함을 확인하였다. ② 조사 양식(ver. 2.1)의 A~I 전 항목을 실제 사례에 적용하여 기재 가능성과 작성 부담을 점검하고, 그 결과를 양식 확정에 반영하였다. ③ 학습 단계·개발모델·수업모델 분류 항목이 실제 프로그램을 판별하는 데 작동함을 확인하여, 전국 사례 취합 시 유형 분류의 준거로 사용할 수 있음을 확인하였다.

5. 학술적 성과

연번	제목	유형	학술지·학술대회명	일자·상태
–	해당 없음	–	–	–

6. 확산·홍보 실적

구분	내용	대상·규모	일자
성과공유세미나 발표	제2회 의과대학 교육혁신 지원사업 성과공유세미나 - 「역량에서 교육과정으로: IPE」 (발표: 오히진)	KAMC 주관, 전국 의과대학 대상	2026. 3. 30.

7. 산출물 저작권 및 관리

산출물명	저작권 귀속	공개 범위	관리 주체
IPE 핵심역량 체계(5영역 20진술문)			
IPE 프로그램 설계·운영 사례 조사 양식			
전국 의과대학 IPE 프로그램 설계·운영 사례 보고서			

06 성과지표 달성도 및 자체평가

1. 성과지표 달성도

연번	성과지표명	목표	실적	달성률	판정 근거·증빙
1	[KPI] 공통 IPE 모듈 개발 여부	Y	표준형 IPE 모듈 미개발	미달	산출물 총괄표(VI-2) — 개발 산출물은 역량 체계·정의문·졸업성과 매칭표·조사 양식으로, KPI가 정의한 '시뮬레이션·온라인·케이스 기반 모듈'에 해당하지 않음
2	[KPI] 참여 의과대학 비율	(Y1 목표 없음)	—	해당 없음	Y2 목표 10%
3	[KPI] 교원 역량강화 연수 참여율	Y	워크숍1회개최	달성	워크숍 일정표 및 강의자료, 참석자 명단, 워크숍 산출물 8건
4	[KPI] 우수사례 도출 및 공유 여부	(Y1 목표 없음)	—	해당 없음	Y2 목표 Y
5	[내부] IPE 핵심역량 체계 개발 (관련 목표 ①)	-	IPE 역량체계 개발	-	
6	[내부] 졸업성과 매칭 (관련 목표 ①)	-	IPE 역량체계-KAMC 기본의학 교육 졸업성과 매칭표 1건	-	매칭표
7	[내부] IPE 프로그램 사례 조사 양식 개발 (관련 목표 ①, ②)	-	1종 + 적용 예시 사례 3건	-	제5차 회의록, 양식 및 사례 원본
8	[내부] 전국 사례 자료 취합 (관련 목표 ①, ②)	-	0개교 (미착수)	-	—

2. 목표 미달·초과 항목 분석

지표	구분(미달/초과)	원인 분석	보완 계획
IPE 프로그램 사례 취합 (전국 자료 취합·사례집 발간)	미달 (자료 취합 진행 중)	본 과제의 사례 취합은 개발된 역량 체계를 준거로 운영 현황을 조사하는 것이므로, 역량 체계 확정이 선행되어야 한다. 역량 체계는 2026년 7월에 확정되었고, 조사 양식은 제5차 회의(2026. 6.)에서 개발을 마쳤으나 전국 대상 자료 요청 단계에는 이르지 못하였다.	① 1차년도 잔여기간 내 전국 의과대학 대상 자료 요청 착수② 회신 지연 시 2차년도 1분기까지 취합을 완료하고, 2차년도 운영 모형 도출의 입력자료로 연계
공통 IPE 모듈 개발 여부	미달	모듈을 개발하려면 ① 목표 역량과 ② 설계 준거가 선행되어야 한다. 제3차 회의에서 역량 도출을 우선 과제로 결정하였고, 이후 역량 체계 확정(2026. 7.)까지 1차년도 자원이 투입되어 모듈 개발 단계에 이르지 못하였다. 제1차 세미나에서 제안된 'K-MedU 용 4시간 분량 모듈 3~4개 개발' 안도 착수하지 못하였다.	① 확정된 역량 체계와 프로그램 설계·운영 양식을 준거로 2차년도에 표준형 모듈 개발 착수② 제4차 워크숍에서 8개 팀이 작성한 IPE 프로그램 산출물을 모듈 설계의 기초자료로 활용③ 사례 취합 결과에서 확인되는 우수 운영 형태를 모듈 유형 선정에 반영

3. 자체 평가

구 분	내 용
잘된 점(강점)	① 의학·간호·약학·사회복지·병원을 포괄하는 다전문직 패널을 구성하여, IPE 역량 체계에 요구되는 다전문직 타당성을 확보하였다. ② 조사도구에 역량 적용 대상('의과대학생 및 보건의료전공계열 학생')을 명시하여 패널 간 평정 준거를 통일하였다. 실제로 "의과대학생 수준에서 역량 수준이 높아 보인다"(1.4), "학생 수준이 아니다" 등 학습자 수준을 준거로 한 구체적 의견이 제시되어, 이 안내가 실질적으로 작동하였음을 확인할 수 있다. ③ 1차에서 이미 전 문항이 합의 기준을 충족하였음에도 주관식 의견을 근거로 진술문을 통합·이동·정련하고 2차 라운드를 시행함으로써, 합의 수준뿐 아니라 진술문의 구성 타당도와 측정가능성을 함께 확보하였다.
부족한 점(한계)	① 학습자 수준(학년·교육단계)별 역량의 도달 수준을 구분하여 기술하지 못하였다. ② 1차년도 목표(전국 자료 취합) 단계에 이르지 못하였다. 조사 양식은 개발을 마쳤으나 실제 취합이 이루어지지 않아, 역량 체계의 현장 정합성은 아직 확인되지 않은 상태이다. ③ 1차년도에 학술 성과(논문·학술대회 발표)를 산출하지 못하였으나, 현재 작업 중에 있으며 2차년도 과제로 수행할 계획이다.
예상하지 못한 성과	
종합 의견	IPE 핵심역량 체계 개발은 2라운드 델파이를 통해 계획대로 완료되었으며, 전 문항이 합의 기준을 충족하는 등 결과의 질도 확보되었다. 반면 목표 전국 의과대학 IPE 프로그램 사례 취합은 착수하지 못하여 1차년도 목표 달성은 부분적이다. 다만 역량 체계가 확정됨에 따라 사례 취합을 단순 현황 수집이 아닌 역량 정합성 검토를 겸한 조사로 설계할 수 있게 되었으므로, 잔여기간 및 2차년도 초반에 이를 우선 추진하여 지연을 만회할 필요가 있다. 아울러 확정 문안의 재검증, 학습자 도달 수준 설정, 평가도구 개발이 후속 과제로 남아 있다.

07 성과 확산 및 활용 방안

1. 전국 의과대학 보급·확산 방안

확산 대상	확산 방법	시기	기대 효과
전국 의과대학 및 IPE 신규 도입 검토 대학	IPE 프로그램 사례집 배포 (사례 취합 완료 후)	2026. 하반기 (사례 취합 완료 후)	타 대학 운영 모형 참조를 통한 도입 부담 경감
의학교육 관련 학회·성과공유세미나	개발 절차 및 결과 발표	2026. 하반기 ~ 2027. 상반기	방법론 공유 및 타당성 검토 의견 수렴

2. 대학별 적용 사례

3. KAMC 플랫폼·타 과제 연계 방안

- 역량 진술문을 학습성과 코드 체계로 변환하여 포트폴리오 평가 플랫폼의 성과 태깅에 활용
- IPE 모듈을 공유대학 콘텐츠로 제출
- 공유대학(K-MedU)을 통해 대학 간 공동 IPE 모듈 운영

4. 지속 가능성 확보 방안

운영 주체 및 관리 체계: KAMC

갱신·고도화 주기 및 방법: 국제 프레임워크 개정 주기 및 국내 교육과정 개편 주기를 고려하여 3~5년 단위 재검토, 필요 시 축약 델파이 시

08 추진 과정의 쟁점·애로사항 및 개선 방안

구분	쟁점·애로사항	원인 및 영향	개선 방안
현장 운영	참여 대학 간 학사일정 조율의 어려움	IPE는 둘 이상 대학·학과와의 공동 운영을 전제하나 기관별 학기·시험 일정이 상이하다. 시범운영에서도 3개 기관 일정 조율이 최대 장애요인으로 확인되었다.	학기 시작 전 공동 일정을 조기 확정하고 외부 장소를 활용하여 일정 유연성을 확보한다(시범운영 적용). 중장기적으로 대학 간 공동 교과목 운영 근거 마련이 필요하다.
제도	의과대학-동반 보건의료계열 대학 간 학점 인정 및 공동 교과 운영 근거 부재	대학 간 공동 교과목 운영에 관한 학사 규정이 정비되어 있지 않아, 프로그램이 비교과에 머무르는 경향이 있다.	교육부·KAMC 차원의 공동 교과목 운영 지침 및 학점 인정 근거 마련이 필요하다(X I 장 참조).
현장 운영	타 기관 학생 간 친밀도 부족으로 인한 초기 상호작용 저하	첫 대면 상황에서 직종 간 인식 차이와 전문 용어 차이가 동시에 작용한다.	아이스브레이킹 시간을 충분히 배치하고(시범운영 70분) 직종별 용어를 사전 안내한다.
현장 운영	활동 시간 부족	단일 일자 운영으로 사례 심화와 디브리핑 시간 확보가 제한된다(시범운영 학생 개선 의견 1순위).	차기 운영 시 활동 시간을 확대하고 사례를 심화하며, 학년별 중단 배치를 검토한다.
인력·보상	다전문직 전문가 패널 확보의 제약	국내에서 IPE 경험을 보유한 전문가 풀이 제한적이어서 연구팀과 델파이 패널의 일부 중복이 불가피하였다.	참여 전문직·기관을 단계적으로 확대하고, 2차년도 확정 문안 재검증 시 신규 패널을 포함하여 독립성을 보완한다.

2차년도·후속 방향

학년별 마일스톤, 질 높은 IPE의 판정 준거, 교육모듈·시나리오·평가 루브릭을 개발하고 시범운영 결과를 역량체계에 반영합니다.